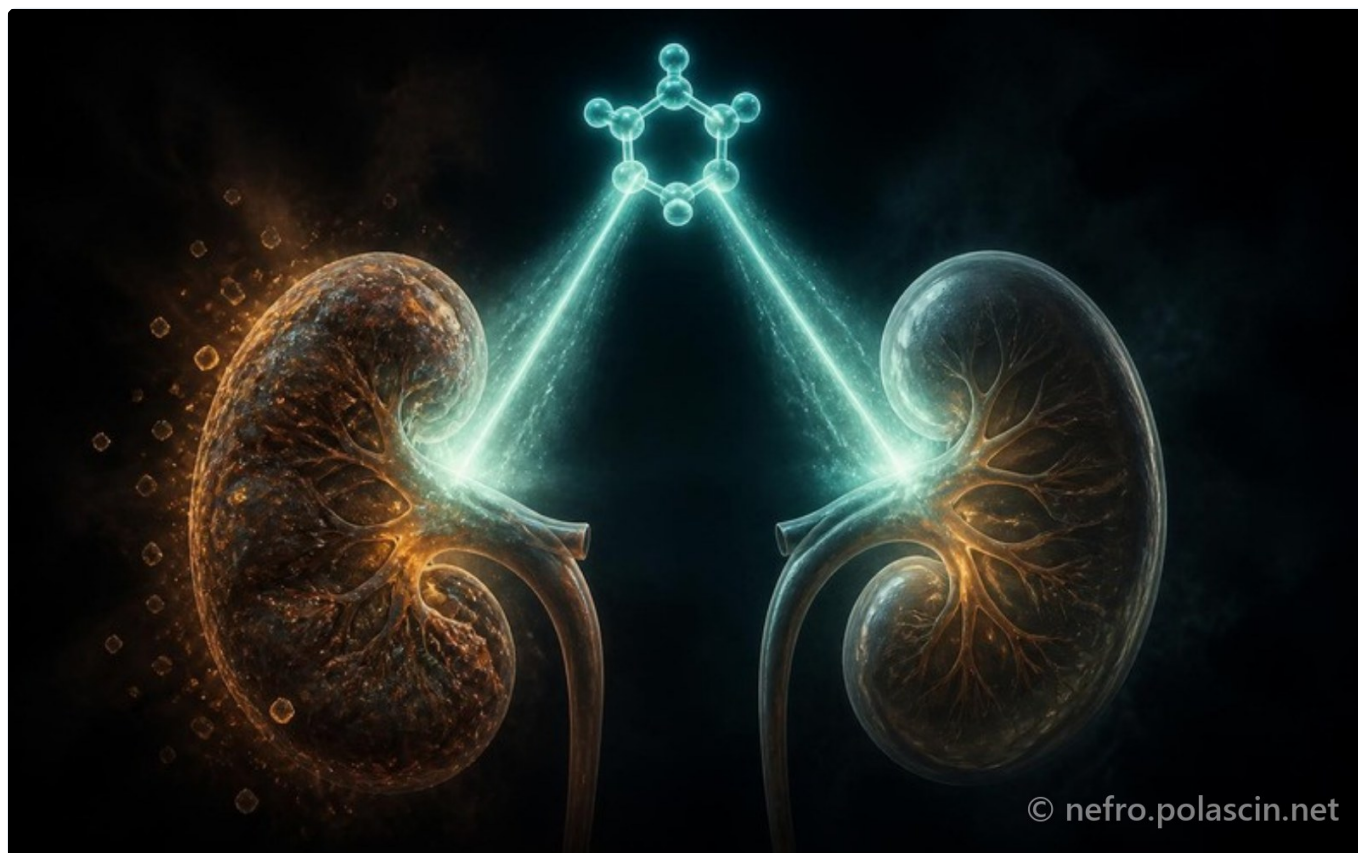


Finerenón: nefroprotektívny účinok aj pri CKD 3-4 bez ohľadu na diabetes

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Ochrana obličky nezávisí od prítomnosti diabetu — to je jadro nálezu.

Portál Physicians Weekly opisuje výsledky štúdie, v ktorej **finerenón** dokázal **spomaliť progresiu chronického ochorenia obličiek (CKD)** u pacientov v **3.-4. štádiu** s **eGFR 20 až 60 ml/min** a **stredne ťažkou až ťažkou albuminúriou**, a to **nezávisle od prítomnosti diabetu**. Text zdôrazňuje aj bezpečnostný aspekt: nárast **hyperkaliémie** sa nepozoroval.

Kto bol v štúdií

Išlo o prospektívne hodnotenie u **180 ambulantných pacientov** v Iraku (CKD 3.-4. štádia; eGFR **20-60 ml/min**; UACR **> 30 mg/g**):

- pri vstupnom hodnotení malo **78 % pacientov diabetes**,
- **36 %** malo eGFR v pásme **20 až 25 ml/min**.

Hlavné výsledky (po 1 roku)

V skupine ako celku:

- **eGFR sa zlepšila**: z približne **32 ± 10** na **47 ± 15 ml/min**,
- **UACR sa znížila**: z približne **542 ± 400** na **180 ± 170 mg/g**.

Analýza podskupín

Pacienti bez diabetu

- eGFR: z približne **33 ± 10** na **50 ± 16 ml/min**,

- UACR: z približne **592 ± 431** na **203 ± 197 mg/g**.

Pacienti s eGFR 20 až 25 ml/min

- eGFR: z približne **21 ± 2** na **36 ± 8 ml/min** po roku,
- UACR: z približne **602 ± 380** na **209 ± 152 mg/g**.

Bezpečnosť: draslík

Článok priamo uvádza, že **finerenón nezvyšoval hladinu sérového draslíka**. Aj v podskupine s eGFR **20-25 ml/min** boli priemerné hodnoty draslíka približne **4,8 ± 0,7 mmol/l na začiatku** a **4,8 ± 0,6 mmol/l po 1 roku**.

Praktické ponaučenie

Tento zdroj prakticky podporuje myšlienku, že u vybraných pacientov s **CKD 3.-4. štádia a významnou albuminúriou** môže mať finerenón **nefroprotektívny prínos aj bez diabetu**. Zároveň však ide o reálnu populáciu (ambulantní pacienti, v texte zjavne v kontexte mimo schválenej indikácie), čo treba do praxe preložiť takto:

- relevantní sú pacienti s albuminúriou (UACR > 30 mg/g) a eGFR v príslušnom rozmedzí,
- a zároveň treba dodržať realistickú klinickú logiku monitorovania draslíka (aj keď v tejto kohorte hyperkaliémia nebola problémom).

Dôležitá opatrnosť pri interpretácii

Text je správou o štúdiu a neuvádza všetky detaily (dizajn, presné parametre a štatistické testy). Pozoruhodné je najmä *zlepšenie* eGFR, ktoré je pri tejto liekovej triede netypické a samo osebe si vyžaduje opatrnú interpretáciu. Preto k záverom pristupujme ako k **signálu** a smeru — praktickú pointu si zaslúžia, ale pred nasadením u konkrétneho pacienta treba držať lokálne odporúčania a bezpečnostné monitorovanie.

Zdroj: *Physicians Weekly: „Finerenone Effective for Stage 3-4 Kidney Disease Regardless of Diabetes Status“.*

[Link na zdroj.](#)

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=finerenon-neproprotekcja-ckd-3-4-bez-ohladu-na-diabetes> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.